



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 998.3/I-PDM/DIR/X/2025

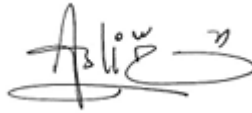
Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Inap

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Rawat Inap



(dr. Yoga Waranugraha, SpJP(K))

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 571.86/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

dan gawat darurat.

- (2) Standar Pelayanan Rawat Inap adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
- (3) Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (4) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- (5) Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- (6) Perawat adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan perawatan.
- (7) Perawat pelaksana harus sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
- (8) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu Pelayanan Rawat Inap.
- b. Memberikan pelayanan kepada pasien rawat inap sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang tepat.
- c. Memberikan pelayanan informasi kesehatan dengan tepat pada pasien dan keluarga sehingga dapat memenuhi hak pasien dan keluarga.
- d. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit meliputi :

- a. Admisi : Pendaftaran pasien dilakukan secara online
- b. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - Laboratorium
 - Radiologi
- c. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter Spesialis.
 - Assesmen awal DPJP dilakukan pada saat DPJP pertama kali kontak dengan pasien meliputi kondisi, diagnosis dan lokasi terindikasi tinggi jatuh berdasarkan indentifikasi
- d. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan.
- e. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter Spesialis.
- f. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- g. Tindakan medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif.
- h. Pemberian obat-obatan pada pasien sesuai dengan catatan daftar obat pasien dan instruksi dokter spesialis
- i. Pelayanan Tranfusi darah
- j. Pemberian surat rujukan

- k. Pemakaian peralatan yang tersedia.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit harus menjamin keselamatan pasien dan hak pasien dan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan di Instalasi Rawat Inap melalui sistem satu pintu.
- (3) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Rawat Inap sebagai penanggung jawab.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari Instalasi Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Instalasi Rawat Inap ikut serta dalam proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien bersama Panitia Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- (2) Setiap insiden yang terjadi pada pasien harus membuat laporan Insiden Keselamatan Pasien.

Pasal 6

- (1) Sistem pendaftaran pasien Rawat Inap dilakukan secara online.
 - a. Pasien masuk rawat inap melalui satu pintu dari IGD.
 - b. Pendaftaran pasien rawat inap dilakukan berdasarkan skrining masuk Rawat Inap.
- (2) Data pasien direkap di billing SIMRS dan dapat di lihat dari semua unit rawat inap.

Pasal 7

- (1) Semua pasien rawat inap dilakukan skrining untuk menetapkan kebutuha pelayanan preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan pasien diberikan sesuai prioritas kebutuhan pasien

Pasal 8

- (1) Penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat inap harus disampaikan kepada pasien.
- (2) Semua pasien diberitahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternative yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dan dicatat di Rekam Medis.

Pasal 9

- (1) Dilakukan rencana pemulangan pasien (Discharge Planning) bagi pasien yang rencana pemulangannya kompleks dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.
- (2) Discharge Planning dilakukan secara terintegrasi antar PPA terkait dan difasilitasi manager pelayanan pasien (MPP)

Pasal 10

- (1) Semua pasien rawat inap ditentukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab mengelola pasien

sesuai dengan kewenangan klinisnya serta melakukan koordinasi dan kesinambungan asuhan.

- a. DPJP yang ditunjuk harus tercatat namanya di rekam medis.
- b. DPJP memberikan keseluruhan asuhan selama pasien di Rumah Sakit dan berkolaborasi serta komunikasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya.

Pasal 11

- (1) Semua pasien rawat inap diberikan informasi tentang rencana asuhan pasien yang didokumentasikan.
- (2) Semua pasien rawat inap diberikan informasi tentang biaya yang di tanggung oleh pasien.

Pasal 12

Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit wajib mengikuti Standar Pelayanan Rawat Inap sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 304/I-PER/DIR/III/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan RidhoNya Pedoman Pelayanan Instalasi rawat Inap dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Instalasi rawat Inap ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi semua pelayanan di Instalasi rawat Inap.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Instalasi rawat Inap ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Pelaksana

1. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
2. Afni Nur Ainy, S. Kep. Ns
3. Khusnul Khotimah, S.Kep, Ns
4. Wiwit Indah Yanti, S. Kep. Ns
5. Very Susanto, S. Kep. Ns
6. Siti Zaimah, AMd. Keb
7. Dhora Meryda, S.Kep, Ns

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	iii
KATA PENGANTAR	vii
TIM PENYUSUN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Batasan Operasioanal	1
1.4. Sasaran	2
1.5. Pengertian	2
BAB II STANDAR KETENAGAAN	3
2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia	3
2.2. Distribusi Ketenagaan	3
2.3. Pengaturan Jaga	4
BAB III STANDAR FASILITAS	5
3.1. Denah Ruang	5
3.2. Standar Fasilitas	5
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN	10
4.1. Pelayanan Rawat Inap Yang Bisa Dilakukan di RSPH	10
4.2. Pelayanan Rawat Inap Yang Tidak Bisa Dilakukan di RSPH	10
BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN	11
5.1. Skrining Pasien Masuk Rawat Inap	11
5.2. Penundaan Dan Kelambatan Pelayanan	12
5.3. Asuhan Pasien Rawat Inap	12
5.4. Kesenambungan Pelayanan Pasien	12
5.5. DPJP	14
5.6. Transfer Pasien	14
5.7. Pemulangan Dari Rumah Sakit	15
5.8. Penolakan Rencana Asuhan Medis	16
5.9. Rujukan Pasien	17
5.10. Transport Pasien	18
BAB VI LOGISTIK	19
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	22
7.1. Pengertian	22
7.2. Tujuan	22
7.3. Standar Keselamatan Pasien	22
7.4. Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan	22
7.5. Tata Laksana	22
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	25
8.1. Latar Belakang	25
8.2. Pengertian	25
8.3. Tujuan	25
8.4. Tata Laksana Keselamatan Kerja	25
8.5. Prinsip Keselamatan Kerja	26
BAB IX PENINGKATAN MUTU	27
9.1. Prinsip	27
9.2. Definisi Indikator	27
9.3. Kriteria	28
9.4. Standar	28
BAB X PENUTUP	30

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1. Gambar Denah Rumah Sakit Prima Husada Malang 31

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kebutuhan pemenuhan kualifikasi SDM 3

Table 2.2 Distribusi Ketenagaan..... 3

Table 2.3 Pengaturan Jaga Rawat Inap 4

Table 3.1 Standar Fasilitas Rawat Inap 5 5

Table 4.1 Pelayanan Rawat Inap..... 10

Table 4.2 Pelayanan Rawat Inap..... 10

Table 5.1 Skrining Pelayanan Rawat Inap..... 11

Table 6.1 Logistik Rawat Inap 19

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 571.86/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI RAWAT INAP

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan rawat inap yang aman dan nyaman merupakan factor penting yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Sesuai visi dan misi RS Prima Husada yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat dan akurat. Pelayanan rawat inap harus bisa diberikan seoptimal mungkin dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien tanpa membedakan status sosial, golongan, suku dan agama.

Pelayanan rawat inap yang meliputi perawatan persalinan, perawatan anak, dewasa dan bedah sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka di Instalasi Rawat Inap perlu dibuat standar pelayanan yang merupakan pedoman bagi semua pihak dalam tata cara pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada pasien pada umumnya. Dalam melakukan pelayanan di Rawat Inap harus berdasarkan standar pelayanan Rawat Inap RS Prima Husada..

1.2. TUJUAN

Pedoman pelayanan instalasi rawat inap ini bertujuan sebagai petunjuk dalam memberikan pelayanan di rawat inap

1. Tujuan Umum
Terwujudnya pelayanan kesehatan di rawat inap dengan mutu tinggi yang mengutamakan keselamatan pasien.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memenuhi kebutuhan perawatan pasien yang dapat dilayani oleh rumah sakit.
 - b. Memberikan pelayanan yang efisien kepada pasien.
 - c. Meningkatkan mutu keselamatan pasien..

1.3. BATASAN OPERASIONAL

1. Ruang perawatan lantai 1
Ruang perawatan di lantai 1 tidak ada.
2. Ruang perawatan lantai 2
Ruang perawatan lantai 2 meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi 2 blok, yang selanjutnya disebut gedung A dan gedung C VIP/VVIP dan 2 ruang *immune compromise*.
3. Ruang perawatan lantai 3
Ruang perawatan lantai 3 meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan yang kesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi 2 blok yaitu Gedung A yang melakukan perawatan dewasa dan didalamnya ada ruang khusus pasien *immune compromise*. Gedung C merupakan ruang perawatan anak sekaligus PICU.
4. Ruang perawatan lantai 4
Ruang perawatan lantai 4 meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan yang kesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi 2 blok

-
- yaitu Gedung A,B dan C. Gedung A perawatan dewasa dan Gedung B,C perawatan Maternal dan Perinatologi.
5. Ruang perawatan lantai 5
Ruang perawatan lantai 5C meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan yang kesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi perawatan dewasa dan ada ruang khusus isolasi *airbone disease*.
 6. Ruang perawatan lantai 6
Ruang perawatan lantai 6A meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan yang kesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi perawatan dewasa
 7. Ruang perawatan lantai 7
Ruang perawatan lantai 7A meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan yang kesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi perawatan dewasa
 8. Ruang perawatan lantai 8
Ruang perawatan lantai 8A meliputi kegiatan pelayanan keperawatan dan pengobatan yang kesinambungan lebih dari 24 jam yang terbagi menjadi perawatan dewasa

1.4. SASARAN

Direktur, dokter dan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.5. PENGERTIAN

1. Pelayanan maternitas : memberikan pelayanan dengan lingkup terbatas yaitu pasien sebelum dan sesudah persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan dengan indikasi dan pasien-pasien ginekologi bila ada.
2. Pelayanan perinatologi : memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir, bayi normal maupun bayi dengan indikasi.
3. Pelayanan rawat inap : memberikan pelayanan kepada pasien secara berlanjut dan berkesinambungan oleh dokter spesialis.
4. Pelayanan isolasi : memberikan pelayanan kepada pasien dengan lingkup terbatas pasien dengan penularan melalui airborne.
5. Pelayanan *Immunocompromised*: memberikan pelayanan pasien dengan lingkup terbatas pasien dengan system kekebalan tubuh (HIV Aids)

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Table 2.1 Kebutuhan Pemenuhan Kualifikasi SDM :

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Sertifikasi
1	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Dokter	PMKP PPI K3RS CODE BLUE KOMUNIKASI EFEKTIF
2	Kepala Bidang Keperawatan	S1 Keperawatan, Ns	PMKP PPI K3RS CODE BLUE KOMUNIKASI EFEKTIF BLS PPI Dasar Manajemen Bangsal
3	Kepala Instalasi Rawat Inap	Dokter	PMKP PPI K3RS CODE BLUE KOMUNIKASI EFEKTIF
4	Kepala Ruang	S1 Keperawatan, Ns D4 Keperawatan D3 Keperawatan	PMKP PPI K3RS CODE BLUE KOMUNIKASI EFEKTIF BLS PPI Dasar Manajemen Bangsal
5	Perawat Pelaksana	S1 Keperawatan, Ns D4 Keperawatan D3 Keperawatan	BLS PPI Dasar PMKP

2.2. Distribusi Ketenagaan

Table 2.2 Distribusi Ketenagaan :

No	Jabatan	IRNA	Kualifikasi	Jumlah SDM	Standart Ketenagaan
1	Ka Bidang Pelayanan Medis	IRNA IRJA Unit Intensive IKO IGD	1 Shift	1	1
2	Ka Bidang Keperawatan	IRNA IRJA	1 Shift	0	1

		Unit Intensive IKO IGD			
3	Ka Instalasi Rawat Inap	IRNA	1 Shift	1	1
4	Ka Ruang	IRNA	1 Shift	7	7
5	Bidan Pelaksana	Maternitas	3 Shift	9	9
6	Perawat Pelaksana	Lantai 2 Gedung A	3 Shift	5	5
7	Perawat Pelaksana	Lantai 3 Gedung A	3 Shift	6	6
8	Perawat Pelaksana	Lantai 4 Gedung A	3 Shift	6	7
9	Perawat Pelaksana	Lantai 2 Gedung C	3 Shift	5	6
10	Perawat Pelaksana	Lantai 3 Gedung C	3 Shift	10	13
11	Perawat Pelaksana	Lantai 5 Gedung C	3 Shift	8	8
12	Perawat Pelaksana	Lantai 6 Gedung A	3 Shift	7	7
13	Perawat Pelaksana	Lantai 7 Gedung A	3 Shift	7	7
14	Perawat Pelaksana	Lantai 8 Gedung A	3 Shif	7	7
15	Perawat Pelaksana	Perinatologi	3 Shift	8	11

2.3. Pengaturan Jaga

Table 2.3 Pengaturan Jaga Rawat Inap :

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Ka Instalasi	1 shift	Jam 08.00-16.00	1 orang
2	Ka Ruang	1 Shift	Jam 08.00-16.00	9 orang
3	Pelaksana Maternitas	3 Shift	Jam 06.30-14.00	3 orang
			Jam 14.00-21.00	3 orang
			Jam 21.00-06.30	2 orang
4	Pelaksana IRNA lantai 2C	3 Shift	Jam 06.30-14.00	2 orang
			Jam 14.00-21.00	2 orang
			Jam 21.00-06.30	1 orang
5	Pelaksana IRNA lantai 2A	3 sHIF	Jam 06.30-14.00	1 orang
			Jam 14.00-21.00	1 orang
			Jam 21.00-06.30	1 orang
6	Pelaksana IRNA lantai 3A	3 Shift	Jam 06.30-14.00	4 orang
			Jam 14.00-21.00	3 orang
			Jam 21.00-06.30	3 orang
7	Pelaksana IRNA lantai 4A	3 Shif	Jam 06.30-14.00	4 orang
			Jam 14.00-21.00	3 orang
			Jam 21.00-06.30	3 orang
8	Pelaksana IRNA lantai 3C	3 Shift	Jam 06.30-14.00	4 orang
			Jam 14.00-21.00	3 orang
			Jam 21.00-06.30	3 orang
9	Pelaksana IRNA lantai 4C	3 Shift	Jam 06.30-14.00	4 orang
			Jam 14.00-21.00	4 orang
			Jam 21.00-06.30	3 orang
10	Pelaksana IRNA lantai 5C	3 Shift	Jam 06.30-14.00	3 orang
			Jam 14.00-21.00	2 orang
			Jam 21.00-06.30	2 orang
11	Pelaksana IRNA lantai 6A	3 Shift	Jam 06.30-14.00	3 orang

			Jam 14.00-21.00	2 orang
			Jam 21.00-06.30	2 orang
12	Pelaksana IRNA lantai 7A	3 Shift	Jam 06.30-14.00	3 orang
			Jam 14.00-21.00	2 orang
			Jam 21.00-06.30	2 orang
13	Pelaksana IRNA lantai 8A	3 Shift	Jam 06.30-14.00	3 orang
			Jam 14.00-21.00	2 orang
			Jam 21.00-06.30	2 orang
14	Pelaksana Perinatologi	3 Shift	Jam 06.30-14.00	2 orang
			Jam 14.00-21.00	2 orang
			Jam 21.00-06.30	2 orang

BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1. Denah Ruang

Ada pada lampiran

3.2. Standar Fasilitas

Letak ruang rawat inap harus di lokasi yang tenang, aman, dan nyaman.

1. Ruang rawat inap harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang pelayanan lainnya
2. Ruangan perawatan pasien di ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis penyakit.

Table 3.1 Standar Fasilitas Rawat Inap :

No	Nama Ruang	Persyaratan Ruang	Keterangan
1.	Ruangan Perawatan	Ukuran ruangan rawat inap tergantung kelas perawatan dan jumlah tempat tidur. 1. Jarak antar tempat tidur 2,4 m minimal luas per tempat tidur 10 meter persegi; jarak antar-tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal tempat tidur per ruangan 4 buah; tempat tidur dapat disesuaikan (<i>adjustable</i>) dan berukuran 200x90x50-80 sentimeter 2. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. 3. Antar tempat tidur yang dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/ menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif. 4. Setiap tempat tidur di ruang rawat inap memiliki 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus serta bel perawat/nurse call yang terhubung dengan pos perawat/nurse station 5. Nakas per tempat tidur. 6. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. 7. Pengaturan suhu dalam ruangan rawat inap harus berada pada rentang 20oC hingga 26oC (Suhu kamar). Pengaturan kelembaban ruangan adalah ≤ 60%. Pengukuran	Jumlah tempat tidur menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian kebutuhan pelayanan.

		suhu dan kelembaban dilakukan menggunakan thermometer dan hygrometer ruangan secara berkala 8. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 250 lux untuk penerangan, dan 50 lux untuk tidur. 9. Ruang rawat dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Penyakit (Infeksi, Non Infeksi), dan ruang rawat gabung. 10. Di setiap ruangan perawatan harus disediakan kamar mandi. Kamar mandi ini mengikuti persyaratan kamar mandi aksesibilitas. 11. Setiap tempat tidur memiliki outlet oksigen yang dilengkapi dengan flowmeter yang berada pada dinding belakang tempat tidur pasien (bedhead).	
2.	Ruangan Laktasi	Mengikuti persyaratan ruang laktasi seperti pada penjelasan sebelumnya.	Ruangan ini khusus disediakan di ruang perawatan kebidanan.
3.	Ruangan Pos Perawat (<i>Nurse Station</i>)	1. Luas ruangan pos perawat minimal 8 m² atau 3-5 m² per perawat, disesuaikan dengan kebutuhan. Satu pos perawat melayani maksimal 25 tempat tidur. 2. Luas ruangan harus dapat mengakomodir lemari arsip dan lemari obat. 3. Disediakan instalasi untuk alat komunikasi. 4. Disediakan fasilitas desinfeksi tangan (<i>handsrub</i>). 5. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux untuk penerangan.	
4.	Ruangan Konsultasi	Umum	RS Kelas C dan D dapat bergabung dengan ruangan pos perawat.
5.	Ruangan Tindakan	1. Luas ruangan per tempat tidur resusitasi 12-20 m². 2. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. 3. Setiap tempat tidur disediakan minimal 5 (lima) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/	Jumlah ruangan tindakan menyesuaikan dengan kajian kebutuhan kapasitas pelayanan.

		sambungan langsung tanpa pengamanan arus. 4. Harus disediakan outlet gas medik yang terdiri dari oksigen, udara tekan medik dan vakum medik. 5. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 15 kali per jam. 6. Ruang harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 300 lux.	
6.	Ruangan Dokter Jaga	Umum	RS Kelas D ruangan ini dapat terpusat.
7.	Ruangan Kepala Rawat Inap	Umum	RS Kelas D ruangan ini dapat terpusat.
8.	Ruangan Linen Bersih	Disediakan lemari atau rak.	RS Kelas C dan D ruangan ini dapat digabung
9.	Gudang Bersih	Umum	
10.	Gudang Kotor (<i>Spoolhoek/ Dirty Utility</i>)	1. Dilengkapi dengan <i>sloop sink</i> dan <i>service sink</i>. 2. Letak ruang <i>spoolhoek</i> berada di area servis. 3. Persyaratan ventilasi udara : 4. Tekanan udara dalam ruangan negatif. 5. Total pertukaran volume udara min. 10 kali per jam.	
11.	KM/WC (Toilet)	1. Toilet petugas mengikuti persyaratan toilet umum (lihat poin di atas). 2. Satu toilet melayani satu ruangan perawatan. 3. Toilet di ruangan rawat inap harus aksesibel untuk pasien (Persyaratan tentang toilet aksesibel melihat poin di atas) dan tersedia tombol panggil bantuan perawat	
12.	Dapur Kecil (<i>Pantry</i>)	1. Dilengkapi dengan sink dan meja pantri. 2. Dilengkapi meja dan kursi makan sesuai dengan kebutuhan.	Ruangan ini dapat terpusat di RS
13.	Janitor/ Ruang Petugas Kebersihan	Umum	Untuk RS kelas D, ruangan ini dapat terpusat di RS
14.	Ruangan Perawatan Isolasi	1. Ukuran ruangan perawatan isolasi minimal 3x4 m². 2. Satu ruangan untuk satu tempat tidur.	Untuk RS kelas C dan D, ada/tidak ruangan ini

		3. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. 4. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. 5. Harus disediakan outlet oksigen dan vakum medik. 6. Disediakan toilet pasien. 7. Dilengkapi wastafel pada ruangan antara. 8. Persyaratan ventilasi udara sebagai berikut : a. Ruangan bertekanan lebih negatif dari ruangan disebelahnya. b. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali/jam. c. Dilengkapi ruangan antara (<i>airlock</i>) jenis <i>sink</i>, dimana <i>airlock</i> bertekanan lebih negatif dibandingkan ruangan-ruangan disebelahnya. 9. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux untuk penerangan, dan 50 lux untuk tidur. 10. Ruang perawatan isolasi harus menyediakan <i>nurse call</i> yang terhubung ke pos perawat (<i>nurse station</i>).	disesuaikan kajian kebutuhan pelayanan.
15.	Ruangan Perawatan <i>Immunocompromised</i>	1. Ukuran ruangan perawatan minimal 3x4 m2. 2. Satu ruangan untuk satu tempat tidur. 3. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. 4. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. 5. Harus disediakan outlet oksigen dan vakum medik. 6. Disediakan toilet pasien. 7. Dilengkapi wastafel pada ruangan antara. 8. Persyaratan ventilasi udara sebagai berikut :	Untuk RS kelas C dan D, ada/ tidak ruangan ini disesuaikan kajian kebutuhan pelayanan.

		a. Ruangan bertekanan lebih positif dari ruangan disebelahnya. b. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali/ jam. 9. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux untuk penerangan, dan 50 lux untuk tidur. 10. Ruang perawatan harus menyediakan <i>nurse call</i> yang terhubung ke pos perawat (<i>nurse station</i>).	
--	--	---	--

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1. Pelayanan Rawat Inap Yang Bisa Dilakukan di RSPH

Table 4.1 Pelayanan Rawat Inap :

Kuratif	Rehabilitatif	Paliatif
1. Typhoid Fever 2. Dengue Fever 3. TBC 4. GEA 5. Appendix 6. Hernia 7. Hemoroid 8. BPH 9. Tonsilitis 10. Gastritis akut	1. CVA Trombosis 2. HT 3. DM 4. CHF 5. Fraktur tulang tanpa komplikasi 6. Diabetic foot 7. Decubitus 8. COPD	1. CKD tanpa hemodialisa 2. Kanker tanpa kemoterapi

4.2. Pelayanan Rawat Inap Yang Tidak Bisa Dilakukan di RSPH

Table 4.2 Pelayanan Rawat Inap :

Jenis Penyakit	Tindak Lanjut
1. HIV baru belum pengobatan 2. COB/ COS dengan pro trepanasi 3. Stemi dengan pro kateterisasi jantung 4. CVA ICH pro trepanasi 5. DVT pro operasi 6. Kanker pro kemoterapi 7. Fraktur Thoraco lumbal 8. CKD pro hemodialisa 9. Fraktur costae yang menyebabkan hemothorax dengan pro WSD	Rujuk RS yang memiliki pelayanan sesuai dengan tujuan rujukan

BAB V
TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1. Skrining Pasien Masuk Rawat Inap

Pada waktu skrining dan pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses asesmen membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien. Pelayanan preventif (dalam proses admisi) adalah untuk mencegah perburukan/ komplikasi.

Table 5.1 Skrining Pelayanan Rawat Inap :

Unit	Ruang	Kamar	Kriteria
Irna lantai 4C	Maternitas	Bougenvil	Obstetri Ginekologi
	Perinatologi	Bangsar	Pasien bayi baru lahir
	Blok C	Viola	Pasien VVIP Interna, Syaraf, Paru, Obgin, THT, Bedah, Cardio, Anak, Obgin
		Anggrek	Pasien VIP Interna, Syaraf, Paru, Obgyn, THT, Bedah, Cardio, Anak, Obgin
		Bougenfil	Pasien Interna, Syaraf, Paru,THT, Bedah, Cardio, Anak, Obgin
Irna Lantai 3	Blok A	Cempaka	Pasien Interna, Syaraf, Paru, Ginek, THT, Bedah, Cardio
		Dahlia	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio
		Isolasi <i>Immunocompromised</i>	HIV dengan pengobatan dan perbaikan kondisi umum
	Blok C	Bogenvil	Pasien anak, Obgyn, Bedah anak
		Cempaka	Pasien anak, Obgyn, Bedah anak
		Dahlia	Pasien anak, Obgyn, Bedah anak
Irna Lantai 4	Blok C	Bogenvil	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio, Mata
		Cempaka	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio, Mata
		Dahlia	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio, Mata
Irna lantai 5	Blok C	Bogenvil	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio, Anak, Mata

		Dahlia	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio. Mata
		Isolasi <i>airbone disease</i>	Pasien TBC
Irna Lantai 6,7,8	Blok A	Dahlia	Pasien Interna, Syaraf, Paru, THT, Ginek, Bedah, Cardio, Mata

5.2. Penundaan Dan Kelambatan Pelayanan

Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu.
 Penundaan pelayanan yang dapat terjadi di Rumah Sakit Prima Husada antara lain:

1. Pelaksanaan rujukan
 Penyebab : menunggu rundingan dari pihak keluarga dan Rs tujuan rujukan masih penuh
2. Pemeriksaan MRI
 Penyebab : MRI dilakukan di Rumah Sakit rujukan, karena Rumah Sakit Prima Husada belum memiliki MRI.

Pasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dicatat di rekam medis

5.3. Asuhan Pasien Rawat Inap

Saat diputuskan rawat inap, dokter yang memutuskan rawat inap memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien/ keluarga dan pemberian informasi didokumentasikan.

5.4. Kesiambungan Pelayanan Pasien

1. Kebutuhan Perencanaan Pemulangan Pasien
 Kesiambungan asuhan pasien setelah dirawat inap memerlukan persiapan dan pertimbangan khusus bagi sebagian pasien seperti perencanaan pemulangan pasien (P3)/ *discharge planning*.
 Penyusunan Perencanaan Pemulangan pasien diawali saat proses asesmen awal rawat inap dan membutuhkan waktu agak panjang, termasuk pemutakhiran/ updating.
 Untuk identifikasi pasien yang membutuhkan Perencanaan Pemulangan Pasien maka rumah sakit menetapkan mekanisme dan kriteria.
 Kriteria pasien yang membutuhkan Perencanaan Pemulangan Pasien antara lain:
 - a. Bayi kurang bulan dengan berat badan lahir rendah
 - b. Pasien usia lanjut dengan demensia
 - c. Pasien dengan gangguan mobilitas, sehingga tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk aktifitas
 - d. Pasien yang masih memerlukan pertolongan untuk melanjutkan terapi atau perawatan
 Rencana pulang termasuk pendidikan/ pelatihan khusus yang mungkin dibutuhkan pasien dan keluarga untuk kontinuitas (kesinambungan) asuhan di luar rumah sakit.
 Kesiambungan asuhan pasca rawat inap akan berhasil bila penyusunan

Perencanaan Pemulangan Pasien dilakukan secara terintegrasi antarprofesional pemberi asuhan (PPA) terkait/ relevan dan difasilitasi Manajer Pelayanan Pasien (MPP).

Proses P3 dan pelaksanaannya di catat di rekam medis *discharge planing*.

2. Proses Kesenambungan Layanan.

Perjalanan pasien di rumah sakit mulai dari admisi, keluar pulang, atau pindah melibatkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA), unit kerja, dan MPP. Selama dalam berbagai tahap pelayanan, kebutuhan pasien dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di rumah sakit dan kalau perlu sumber daya dari luar.

Kesenambungan pelayanan berjalan baik jika semua pemberi pelayanan mempunyai informasi yang dibutuhkan tentang kondisi kesehatan pasien terkini dan sebelumnya agar dapat dibuat keputusan yang tepat.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan dengan pola pelayanan berfokus pada pasien (Patient/ Person Centered Care–PCC). Pola ini dipayungi oleh konsep WHO: Conceptual framework integrated people-centred health services. (WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016–2026, July 2015).

Pelayanan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk Asuhan Pasien

Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap profesional pemberi asuhan (PPA) adalah sama pentingnya atau sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda maka peranan manajer pelayanan pasien (MPP) penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai terhadap profesional pemberi asuhan (PPA). Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berpusat pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.
Proses asuhan pasien terintegrasi melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga.
- b. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai Ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (Clinical Leader).
- c. Profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya. Alur Klinis/ Clinical Pathway terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, Standing Order dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi).
- d. Perencanaan pemulangan pasien (P3) /Discharge Planning terintegrasi.
- e. Asuhan gizi terintegrasi.
- f. Manajer pelayanan pasien/case manager.

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) bukan merupakan profesional pemberi asuhan (PPA) aktif dan dalam menjalankan manajemen pelayanan pasien mempunyai peran minimal adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien;
- b. Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;
- c. mengoptimalkan proses reimbursemen dan dengan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Asesmen untuk manajemen pelayanan pasien.
 - 2) Perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien.
 - 3) Komunikasi dan koordinasi.
 - 4) Edukasi dan advokasi.
 - 5) Kendali mutu dan biaya pelayanan pasien.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen pelayanan pasien antara lain adalah:

- a. Pasien mendapat asuhan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Terpelihara kesinambungan pelayanan.
- c. Pasien memahami/mematuhi asuhan dan peningkatan kemandirian pasien.
- d. Kemampuan pasien mengambil keputusan.
- e. Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga.
- f. Optimalisasi sistem pendukung pasien
- g. Pemulangan yang aman.
- h. Kualitas hidup dan kepuasan pasien

5.5. DPJP

Asuhan pasien diberikan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) berperan sebagai ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (clinical leader). DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial yg sesuai dengan proses UU.

Untuk mengatur kesinambungan asuhan selama pasien berada di rumah sakit, maka DPJP bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola pasien sesuai dengan kewenangan klinis.
2. Melakukan koordinasi dan kesinambungan asuhan.
3. Bertugas dalam seluruh fase asuhan rawat inap pasien serta teridentifikasi dalam rekam medis pasien.

Pengaturan perpindahan tanggung jawab.

Pengaturan perpindahan tanggung jawab merupakan koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama adalah sebagai berikut:

1. Rawat bersama.
Rawat bersama adalah bila dilaksanakan rawat bersama ditetapkan DPJP utama sebagai koordinator asuhan pasien.
2. Konsul.
Konsul adalah penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab melakukan koordinasi asuhan dengan DPJP lain dan bertugas dalam seluruh fase asuhan rawat inap pasien serta teridentifikasi dalam rekam medis pasien.
3. Alih rawat.
Alih rawat adalah proses pengaturan perpindahan tanggung jawab dan koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama.

5.6. Transfer Pasien

Selama dirawat inap di rumah sakit, pasien mungkin dipindah dari satu pelayanan atau dari satu unit rawat inap ke berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain. Jika profesional pemberi asuhan (PPA) berubah akibat perpindahan ini maka informasi penting terkait asuhan harus mengikuti pasien. Pemberian obat dan tindakan lain dapat berlangsung tanpa halangan dan kondisi pasien dapat dimonitor. Untuk memastikan setiap tim asuhan menerima informasi yang diperlukan maka rekam medis pasien ikut pindah atau ringkasan informasi yang ada di rekam medis disertakan waktu pasien pindah dan menyerahkan kepada tim asuhan yang menerima pasien. Bila pasien dalam pengelolaan manager pelayanan pasien (MPP) maka kesinambungan proses tersebut dipantau, diikuti dan transfernya disupervisi

oleh manager pelayanan pasien (MPP).

Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien. Form transfer pasien RSPH memuat :

1. Indikasi pasien masuk dirawat.
2. Riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostik.
3. Setiap diagnosis yang dibuat.
4. Setiap prosedur yang dilakukan.
5. Obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan.
6. Keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer).

5.7. Pemulangan Dari Rumah Sakit

Merujuk atau mengirim pasien ke praktisi kesehatan di luar rumah sakit, unit pelayanan lain, rumah, atau keluarga didasarkan atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhannya untuk memperoleh kesinambungan asuhan.

Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bertanggung jawab atas asuhan pasien menentukan kesiapan pasien keluar rumah sakit berdasarkan kebijakan, kriteria, dan indikasi rujukan yang ditetapkan rumah sakit.

Kebutuhan kesinambungan asuhan berarti rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik, atau bahkan kebutuhan upaya preventif di rumah yang dikoordinasikan oleh keluarga pasien. Diperlukan proses yang terorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa kesinambungan asuhan dikelola oleh praktisi kesehatan atau oleh sebuah organisasi di luar rumah sakit. Pasien yang memerlukan perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) maka rumah sakit mulai merencanakan hal tersebut sedini mungkin yang sebaiknya untuk menjaga kesinambungan asuhan dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait/ relevan serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Keluarga dilibatkan dalam proses ini sesuai dengan kebutuhan.

Rumah sakit dapat menetapkan regulasi tentang kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting. Menetapkan kriteria tentang pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit selama periode waktu tertentu.

1. Proses Pemulangan Pasien Dari Rumah Sakit.
 - a. Ditentukan kriteria pemulangan pasien yang rencana pemulangannya kompleks (*discharge planning*) untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.
 - b. Terdapat bukti pemulangan pasien sesuai dengan kriteria pemulangan pasien.
 - c. Ditentukan kriteria tentang pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit selama periode waktu tertentu.
 - d. Terdapat bukti pelaksanaan tentang pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit selama periode waktu tertentu.

2. Tindak Lanjut Pemulangan

Dibutuhkan perencanaan untuk mengatur tindak lanjut pemulangan pasien ke praktisi kesehatan atau organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan kesinambungan asuhan pasien.

Pasien membutuhkan pelayanan dukungan dan pelayanan kesehatan pada waktu pasien keluar dari rumah sakit (*discharge*).

Proses perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait serta

difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP) dan memuat bentuk bantuan pelayanan yang dibutuhkan dan ketersediaan bantuan yang dimaksud adalah :

- a. Ada bukti pemulangan pasien yang rencana pemulangannya kompleks
- b. (discharge planning) dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.
- c. Pada tindak lanjut pemulangan pasien bila diperlukan dapat ditujukan kepada fasilitas kesehatan baik perorangan ataupun institusi yang berada di komunitas dimana pasien berada yang bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan.

3. Ringkasan Pemulangan Pasien.

Ringkasan pasien pulang (*discharge summary*) dibuat untuk semua pasien rawat inap. Ringkasan pasien pulang memberikan gambaran tentang pasien yang tinggal dirumah sakit. Ringkasan dapat digunakan oleh praktisi yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan.

Ringkasan memuat hal:

- a. Indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis, dan komorbiditas lain.
- b. Temuan fisik penting dan temuan-temuan lain.
- c. Tindakan diagnostik dan prosedur terapi yang telah dikerjakan.
- d. Obat yang diberikan selama dirawat inap dengan potensi akibat efek residual setelah obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan di rumah.
- e. Kondisi pasien (status present).
- f. Ringkasan memuat instruksi tindak lanjut agar dihindari istilah anjuran.

Ringkasan pasien pulang dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien/ keluarga dan memuat instruksi antara lain :

- a. Riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostik.
- b. Indikasi pasien dirawat inap, diagnosis, dan komorbiditas lain.
- c. Prosedur terapi dan tindakan yang telah dikerjakan.
- d. Obat yang diberikan termasuk obat setelah pasien keluar rumah sakit.
- e. Kondisi kesehatan pasien (status present) saat akan pulang dari rumah sakit.
- f. Instruksi tindak lanjut dan dijelaskan kepada pasien dan keluarga.

Ringkasan pasien pulang dibuat sebelum pasien keluar dari rumah sakit oleh dokterpenanggung jawab pelayanan (DPJP). Satu salinan/ copy dari ringkasan diberikan kepada:

- a. Tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan kepada pasien.
- b. Pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit yang mengacu padaperaturan perundangan yang berlaku.
- c. Penjamin.
- d. Salinan ringkasan berada di rekam medis pasien.

5.8. Penolakan Rencana Asuhan Medis

Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, kemudian pasien ini memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis.

Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit.

Pasien yang menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian yaitu :

1. Jika seorang pasien rawat yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian.
2. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter. maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit.

Jika pasien mempunyai dokter keluarga dan dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut. Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses.

1. Pasien Yang Menolak Rencana Asuhan Medis Termasuk Keluar Rumah Sakit Atas Permintaan Sendiri.
 - a. Pengelolaan pasien rawat inap yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan antara lain:
 - 1) Edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap.
 - 2) Pasien keluar rumah sakit atas permintaan sendiri tetap mengikuti proses pemulangan pasien.
 - 3) Beritahu dokter keluarga atau dokter yang memberi asuhan berikutnya tentang kondisi pasien tersebut.
 - b. Dokumentasi rumah sakit berisi pengkajian untuk mengetahui alasan pasien keluar rumah sakit atas apakah permintaan sendiri, menolak asuhan medis atau tidak melanjutkan program pengobatan antara lain:
 - 1) Bukti penolakan asuhan medis yang ditandatangani oleh pasien dan PPA.
 - 2) Bukti pemberian edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap.
2. Pengelolaan Pasien Rawat Inap Yang Meninggalkan Rumah Sakit Tanpa Pemberitahuan

Jika pasien menolak rencana asuhan medis tanpa memberi tahu siapapun di dalam rumah sakit atau yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa tidak kembali ke rumah sakit harus dilakukan :

 - a. Rumah sakit harus berupaya menghubungi pasien untuk memberi tahu tentang potensi risiko bahaya yang ada.
 - b. Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis.
3. Pengidentifikasian Pasien Menderita Penyakit Yang Membahayakan Dirinya Sendiri
 - a. Identifikasi pasien menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.
 - b. Rumah sakit membuat laporan ke dinas kesehatan atau kementerian kesehatan tentang kasus infeksi dan memberi informasi tentang pasien yang mungkin mencelakakan dirinya atau orang lain.
 - c. Rumah sakit melaporkan ke pada pihak yang berwenang bila ada indikasi kondisi pasien yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.

5.9. Rujukan Pasien

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik.

Rujukan ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal dengan ketentuan :

1. Rujukan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien.
2. Rumah sakit yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk.
3. Ada kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi.

Diperlukan proses konsisten melakukan rujukan pasien untuk memastikan keselamatan pasien yaitu:

1. Ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.
2. Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis.
3. Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan.
4. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.

5.10. Transport Pasien

Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transpor pasien.

1. Pasien dari unit pelayanan kronik atau pusat rehabilitasi yang membutuhkan pelayanan rawat jalan atau evaluasi.
2. Dari unit darurat.
3. Transpor untuk kembali ke rumahnya atau fasilitas lain.

Bergantung pada kebijakan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan apakah ongkos transpor dapat atau tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit. Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, mungkin ambulans atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau teman. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada kondisi dan status pasien. Kendaraan transportasi milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangan dan memenuhi ketentuan antara lain:

1. Alat transportasi pasien harus sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk memenuhi persyaratan PPI.
3. Bila alat transportasi yang digunakan terkontaminasi cairan tubuh pasien atau pasien dengan penyakit menular harus dilakukan proses dekontaminasi.
4. Ada mekanisme untuk menangani keluhan proses transportasi dalam ruang yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, kondisi, dan perawatan kendaraan.

BAB VI LOGISTIK

Berikut daftar logistic yang ada di Instalasi Rawat Inap dibedakan sesuai dengan klasifikasinya

Table 6.1 Logistik Rawat Inap :

Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah
Medis – Listrik	Nebulizer	10 buah
	Termometer digital	1 buah
	Thermo Gun	10 buah
	Lampu Viewer	8 buah
	Alat GDA	9 buah
	Oxymeter	10 buah
	Monitor patient	12 buah
	ECG	6 buah
	Penlight	1 buah
	Syringe pump	11 buah
	Lampu sorot	9 buah
	Infuse pump	2 buah
	Doppler	2 buah
	Suction bayi	1 buah
	Laringoskop neo	1 buah
	Infant warmer	1 buah
	Inkubator	3 buah
	Inkubator transport	1 buah
	C-pap mesin	3 buah
	Cuvis	3 buah
	NST	1 buah
	Lampu fototerapi	2 buah
	Pulse Oxymeter Bionet/ Oxywave neo	4 buah
	Tensi digital	3 buah
	Neo-puff infant T-piece	1 buah
	Pulse Oxymetri portable / Mindray Prq-60	1 buah
	Negatif ion Air Purifier	3 buah
	Inkubator Transport	1 buah
Medis – Non Listrik	Tensimeter	11 buah
	Stetoskop dewasa	11 buah
	Set rawat luka	10 buah
	Kursi roda	6 buah
	Partus set	8 buah
	IUD set	2 buah
	Curet set	4 buah
	Vakum set	1 buah
	Tourniquet	9 buah
	Troli injeksi	11 buah
	Regulator oksigen	88 buah
	Standard infus bed	25 buah
	Starndard infus roda	77 buah
	Box emergency & stock	9 buah
	Hummer patela	1 buah
	Foot step	98 buah
	Tongue spatel	2 buah
	Oxygen transport	4 buah
	Bengkok	11 buah
	Ambubag dewasa	6 buah
	Ambubag anak	1 buah
	Ambubag bayi	1 buah
	Stetoskop anak	4 buah

	Spekulum sym	2 buah
	Spekulum cocor bebek besar	1 buah
	Spekulum cocor bebek sedang	1 buah
	Spekulum cocor bebek kecil	1 buah
	Tang biopsi	1 buah
	Sendok micro curet	1 buah
	Cateter logam	1 buah
	Bed gynecology	4 buah
	Box bayi	12 buah
	Torniquet	2 buah
	Skiren	1 buah
	Kaca mata gogle	1 buah
	Sendok kuret no. 6	1 buah
	Sendok kuret no. 8	1 buah
	Sendok kuret no. 10	1 buah
	Negatif ion Air Purifier	3 buah
BMHP (bahan medis habis pakai)	Alcohol 70%	14 buah
	Hypafix 15 cm x 5 m	7 buah
	Accu Check	6 buah
	Plester Coklat	7 roll
	Kassa gulung	7 roll
	Stik GDA	7 box
	Kertas ECG	6 roll
	Elastomul	7 box
	Jelly KY	6 buah
	Betadin	6 botol
	Silet	1 pak
	Kertas lakmus	1 pak
Farmasi (Box Emergency)	Atropine sulfat 1ml (0,25mg/1ml)	2 buah
	Dobutamine (50mg/ml)	1 buah
	Dexametason 1ml (5mg/ml)	1 buah
	Indop 5ml (40mg/ml)	1 buah
	Epineprin 1ml (1mg/ml)	4 buah
	Natrium Phenytoin 2ml (50mg/ml)	1 buah
	Phenobarbital 1ml (50mg/ml)	1 buah
	Valisanbe 2ml (5mg/ml)	1 buah
	Stesolid rectal (10mg)	1 buah
	Aspilet 80mg	5 buah
	Amiodaron 3ml	4 buah
	Cpg 75mg	5 buah
	Furosemide 2mg	2 buah
	Aminophyline 10ml (24mg/ml)	1 buah
	Bloodset	1 buah
	Infus set makro	1 buah
	Infus Gelafusal 500ml	1 buah
	Infus D5 500ml	1 buah
	Infus D5 ½ NS 500ml	1 buah
	Infus D5 ¼ NS 500ml	1 buah
	Manitol 500ml	1 buah
	Mayo kuning	1 buah
	Lidocaine 2% 2ml	3 buah
	Sput 10cc terumo	3 buah
	Sput 3cc terumo	3 buah
	Sput 5cc terumo	3 buah
	Hi oxygen masker dewasa	1 buah
	Hi oxygen masker anak	1 buah
	Infus set mikro	1 buah
	Iv cath no 20	1 buah
	Iv cath no.22	1 buah
	Iv cath no.24	1 buah

	Iv cath no. 26	1 buah
	Suction Catheter no. 6	1 buah
	Suction Catheter no 8	1 buah
	Three way catheter stopcock	1 buah
Non Medis – Listrik	CCTV	34 buah
	WIFI	7 buah
	Dispenser	13 buah
	Jam dinding	53 buah
	Kulkas	9 buah
	Set AC	50 buah
	Remote TV	50 buah
	TV	53 buah
	Kipas angin	32 buah
	Bel	103 buah
	Lampu besar	309 buah
	Telfon	8 buah
	Computer	11 buah
	Appar	14 buah
Non Medis – Non Listrik	Bantal	103 buah
	Bed pasien	103 buah
	Bed penunggu	8 buah
	Botol handrub	103 buah
	Cermin	41 buah
	Closet	44 buah
	Handwash	7 buah
	Ember plastic	14 buah
	Keset	44 buah
	Kursi	103 buah
	Meja pasien (Nakas)	103 buah
	Pigora	7 buah
	Tempat sampah	49 buah
	Wastafel	44 buah
	Papan dinas	6 buah
	Tong linen	14 buah
	Meja makan pasien	8 buah
	Almari linen	7 buah
	Lemari BHP	7 buah
	Box sample lab	7 buah
	Box injeksi	20 buah
	Staples besar	7 buah
	Staples kecil	14 buah
	Gunting	14 buah
	Dispenser isolasi	7 buah
	Plong-plongan	7 buah
	Trolley map	4 buah
	Box CSSD	7 buah

BAB VII KESELAMATAN PASIEN

7.1. Pengertian

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi penilaian resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Keselamatan pasien di ruang rawat inap merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien, mengingat perawatan pada pasien rawat inap membutuhkan perhatian yang lebih dan membutuhkan penanganan jangka panjang yang perlu keseriusan dari tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan penanganan dalam praktiknya. Kejadian yang mengacu pada keselamatan pasien diantaranya pasien terjatuh dari tempat tidur, pasien diberi obat salah, tidak ada obat/alat emergensi, tidak ada oksigen, tidak ada alat penyedot lendir, tidak tersedia alat pemadam kebakaran, dan pemakaian obat.

7.2. Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di RS.
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

7.3. Standar Keselamatan Pasien

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasif
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

7.4. Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan

Kesalahan dalam sasaran keselamatan pasien bisa menyebabkan kefatalan dalam pelayanan, yaitu bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Contoh dalam hal ini adalah kesalahan dalam mengidentifikasi pada saat sebelum melakukan Tindakan, identifikasi tidak dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO).

7.5. Tata Laksana

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
 - a. Setiap pasien yang masuk rawat inap dipasangkan gelang identitas pasien.
 - b. Gelang identitas untuk pasien laki-laki berwarna biru muda dan gelang identitas untuk perempuan berwarna merah muda. Bila pasien ada resiko jatuh diberi stiker warna kuning dan bila pasien ada alergi diberi stiker warna merah di gelang identitas pasien
 - c. Ada dua identitas yang digunakan yaitu nama dan tanggal lahir yang disesuaikan dengan tanda pengenalan resmi.
 - d. Identifikasi pasien dilakukan pada saat sebelum :

- 1) Melakukan tindakan/ intervensi/ terapi (misalnya pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, melakukan terapi radiasi).
 - 2) Melakukan tindakan (misalnya memasang jalur intravena atau hemodialisa)
 - 3) Sebelum tindakan diagnostic apa pun (misalnya mengambil darah dan specimen lain untuk pemeriksaan laboratorium penunjang, atau sebelum melakukan keterisasi jatung ataupun Tindakan radiologi diagnostic)
 - 4) Menyajikan makanan pasien
 - 5) Staf unit pelayanan
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
 - a. Metode, formulir dan alat bantu ditetapkan sesuai dengan jenis komunikasi agar dapat dilakukan secara konsisten dan lengkap
 - b. Metode komunikasi saat menerima intruksi melalui telepon adalah : menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
 - c. Saat melaporkan metode yang digunakan adalah *Situation – Background – Assessment – Recommendation* (SBAR)
 - d. Metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostic melalui telpon juga dengan menggunakan menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
 - e. Metode komunikasi saat serah terima antar ruangan dan atau di salam ruangan menggunakan formulir khusus
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
 - a. Obat risiko tinggi yaitu obat dengan zat kimia yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan dalam penggunaannya
 - b. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (nama obat rupa dan ucapan mirip/ NORUM, atau LASA(look alike sound alike))
 - c. Elektrolit konsentrat yang melebihi 50%, contoh : KCL 3%, NS 3%.
 - d. Ada protocol dalam pemberian terapi dalam menanggulangi hypokalemia, hyponatremia, dan hipofastemia yang sudah tertera dalam PPK (panduan praktek klinis)
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasive
 - a. Tindakan operasi dan invasive meliputi semua tindakan yang melibatkan insisi atau pungsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, operasi terbuka, aspirasi perkutan, injeksi obat tertentu, biopsy, tindakan intervensi atau diagnostic vaskuler dan kardiak perkutan, laparaskopi, ekstraksi gigi, ESWL, dan endoskopi.
 - b. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien
 - c. Penandaan lokasi tindakan operasi/ invasive dilakukan oleh PPA yang akan melakukan tindakan tersebut
 - d. PPA tersebut akan melakukan seluruh prosedur operasi/ invasive dan tetap berada dengan pasien selama tindakan berlangsung
 - e. Pada tindakan operasi, dokter operator/ dokter penanggung jawab pasien (DPJP) bedah akan melakukan tindakan penandaan lokasi
 - f. Tindakan invasive non-operasi, penandaan dilakukan oleh dokter yang akan melakukan tindakan
 - g. Penandaan dapat dilakukan di area luar kamar operasi
 - h. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali yaitu dengan tanda lingkaran dan panah pada area yang akan dilakukan tindakan
 - i. Tanda harus terlihat sampai pasien disiapkan
 - j. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang)
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan

Kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus segera

dilakukan terutama saat tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan-bahan dari tubuh pasien. Penggunaan handrub dengan bahan alkohol dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan tangan bebas dari kontaminasi atau hanya jika tangan tidak terlihat kotor, bukan menggantikan fungsi cuci tangan. Lakukan cuci tangan pada momen yang tepat, yaitu :

- a. Sebelum kontak langsung dengan pasien.
- b. Setelah kontak langsung dengan pasien.
- c. Sebelum melakukan tindakan invasif pada pasien.
- d. Setelah terkena cairan tubuh pasien.
- e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien

6 langkah cuci tangan menggunakan handwash sebagai berikut :

- a. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih (kran, air yang dituangkan dari wadahnya mengalir tangan). Ambil 3-5cc sabun cair, ratakan dengan kedua telapak tangan.
- b. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan dan sebaliknya.
- c. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua telapak tangan.
- d. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
- e. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya.
- f. Gosok arah berputar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
- g. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
- h. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering.
- i. Tutup kran dengan handuk sekali pakai atau tisu

6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

- a. Pengkajian risiko jatuh pada semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak dilakukan sesuai regulasi Panduan Upaya Mengurangi Cedera Pasien Akibat Jatuh
- b. Pengkajian ulang risiko jatuh pada pasien rawat inap dilakukan pada saat terjadi perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian
- c. Tindakan dan/ atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap telah dilakukan dan didokumentasikan

BAB VIII KESELAMATAN KERJA

8.1. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

8.2. Pengertian

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

8.3. Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

8.4. Tata Laksana Keselamatan Kerja

Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas rumah sakit dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya:

1. Petugas mengerti SPO penggunaan APD sehingga dapat menggunakan APD sesuai prosedur.
2. Tersedianya APD yang memenuhi standar.
3. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum atau pun spuit bekas.
4. Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.
5. Setiap pasien yang menular atau beresiko menular di rawat di ruang isolasi.
6. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi
 - b. Menggunakan alat pelindung (hazmat/ skort, sarung tangan, kacamata, sepatu boot/ alas kaki tertutup, celemek, masker, dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll
 - c. Melakukan tindakan yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, misal : memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
 - d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik pada 5 momen.
7. Terdapat tempat sampah infeksius dan noninfeksius.
8. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin

-
- b. Pencucian dengan sabun
 - c. Pengeringan
9. Menggunakan baju kerja yang bersih

8.5. Prinsip Keselamatan Kerja

Dalam prinsip kesehatan keselamatan kerja (K3) secara utuh di rumah sakit ada 3 komponen penting yang saling berhubungan, antara lain :

1. Kapasitas kerja, kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu.
2. Beban kerja, suatu kondisi yang membebani pekerja baik secara fisik maupun non fisik dalam menyelesaikan pekerjaannya, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik atau non fisik.
3. Lingkungan kerja, kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB IX PENINGKATAN MUTU

9.1. Prinsip

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, pelayanan rawat inap harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu. Dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan rawat inap perlu ada suatu program yang terencana dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi pelayanan rawat inap dalam mengevaluasi dan membuat rencana tindak lanjut sehingga tercapai peningkatan mutu pelayanan yang diharapkan. Indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan Indikator PMKP.

9.2. Definisi Indikator

1. Indikator Mutu Nasional
 - a. Kepatuhan Identifikasi
 - 1) Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan
 - 2) Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit.
 - 3) Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan)
 - 4) Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti :
 - a) Pemberian pengobatan : pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi
 - b) Prosedur tindakan : tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit
 - c) Prosedur diagnostik : pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain
 - d) Kondisi tertentu : pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar
 - 5) Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
 - b. Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Waktu *visite* dokter adalah waktu kunjungan dokter untuk melihat perkembangan pasien yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
 - 1) *Clinical Pathway* adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit.
 - 2) Kepatuhan terhadap *clinical pathway* adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan *clinical pathway* yang ditetapkan Rumah Sakit.
 - d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
 - 1) Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi:
 - a) *Assesment* awal risiko jatuh
 - b) *Assesment* ulang risiko jatuh
 - c) Intervensi pencegahan risiko jatuh
 - 2) Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.

2. Indikator Mutu Prioritas Unit
 - a. Angka Kelengkapan Penulisan Perawat Dalam CPPT
Angka tercapainya kelengkapan perawat dalam penulisan di form rekam medis di bagian CPPT (catatan perkembangan pasien terintegrasi)
3. Indikator Mutu Global Budget
 - a. Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri
 - 1) Pasien pulang tanpa ada persetujuan DPJP
 - 2) Pasien pulang atas permintaan sendiri
 - 3) Pasien pulang dalam kondisi belum membaik
 - b. Angka Rujukan Horizontal FKRTL
Pasien dirujuk dari rawat inap ke rumah sakit dengan tipe yang sama seperti RS. Prima Husada
 - c. Angka Walk Through Audit
Angka tercapainya mutu pelayanan rumah sakit

9.3. Kriteria

1. Indikator Mutu Nasional
 - a. Kepatuhan Identifikasi
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
 - 2) Kriteria Eksklusi : Tidak ada
 - b. Kepatuhan Waktu Visite Dokter
 - 1) Kriteria Inklusi : *Visite* dokter pada pasien rawat inap
 - 2) Kriteria Eksklusi :
 - a) Pasien yang baru masuk rawat inap hari itu
 - b) Pasien konsul
 - c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
 - 1) Kriteria Inklusi : Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup *clinical pathway* yang diukur
 - 2) Kriteria Eksklusi :
 - a) Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan.
 - b) Pasien yang meninggal
 - c) Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan
 - d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
 - 1) Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh
 - 2) Kriteria Eksklusi : Pasien yang tidak dapat dilakukan asesmen ulang maupun edukasi seperti pasien meninggal, pasien gangguan jiwa yang sudah melewati fase akut, dan pasien menolak intervensi
2. Indikator Mutu Prioritas Unit
 - a. Angka Kelengkapan Penulisan Perawat Dalam CPPT
 - 1) Kriteria Inklusi : Perawat yang sedang berdinas di unit rawat inap
 - 2) Kriteria Eksklusi : Perawat yang sedang cuti melahirkan dan sedang sakit
3. Indikator Mutu Global Budget
 - a. Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua pasien pulang atas permintaan sendiri
 - 2) Kriteria Eksklusi : Pasien pulang atas advice DPJP
 - b. Angka Rujukan Horizontal FKRTL
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua pasien rujuk horizontal FKRTL
 - 2) Kriteria Eksklusi : Semua pasien rujuk vertikal FKRTL
 - c. Angka Walk Through Audit
 - 1) Kriteria Inklusi : Angka Walk Through Audit pasien rawat jalan dan rawat inap
 - 2) Kriteria Eksklusi : Tidak ada

9.4. Standar

1. Indikator Mutu Nasional
 - a. Kepatuhan Identifikasi : 100%
 - b. Kepatuhan Waktu Visite Dokter : $\geq 80\%$
 - c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) : $\geq 80\%$
 - d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh : 100%
2. Indikator Mutu Prioritas Unit
 - a. Angka Kelengkapan Penulisan Perawat Dalam CPPT : 100 %
3. Indikator Mutu Global Budget
 - a. Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri : 0%
 - b. Angka Rujukan Horizontal FKRTL : 0%
 - c. Angka Walk Through Audit : 100

BAB X PENUTUP

Pelayanan rawat inap adalah bagian pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada yang memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Dengan adanya pedoman pelayanan rawat inap diharapkan dapat membantu dalam memberikan pelayanan khususnya dirawat inap dan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit terutama PPA dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Sehingga asuhan pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yang berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien karena kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Denah Rumah Sakit Prima Husada Malang

